



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

НАКАЗ

від « 11 » вересня 2023 року

м. Львів

№ 296-В

**Про розподіл та раціональне
використання імунобіологічних
препаратів, отриманих у якості
гуманітарної допомоги**

На виконання наказу МОЗ України від 16.09.2011 року №595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», листів Міністерства охорони здоров'я України від 11.09.2023 №26-04/25494/2-23, від 21.06.2023 року №26-04/16957/2-23 та від 07.07.2023 року №26-04/18551/2-23, Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» від 10.08.2023 № 04-09/29/4441/23, видаткових накладних ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» від 04.07.2023 №9958 та №9936, від 08.08.2023 року №11195 та враховуючи зведені дані щодо потреби у медичних імунобіологічних препаратах, поданих закладами охорони здоров'я Львівської області, –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл імунобіологічних препаратів та витратних матеріалів до них серед закладів-отримувачів медичних імунобіологічних препаратів (МІБП) Львівської області згідно додатку 1 даного наказу:

1.1. Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту ІПВ, серія 2309007А, термін придатності 14.02.2026, 1 доза – в кількості 2227 доз;

1.2. Комбінована жива атенуйована вакцина проти кору, епідемічного паротиту і краснухи (КПК), серія Х008315, термін придатності 02.2025, 1 доза – в кількості 8367 доз;

1.3. Вакцина проти дифтерії, правця та кашлюку АКДП, серія 2822Х010В, термін придатності 12.2024, 10 доз – в кількості 460 доз.

2. Завідувачу складом медичних імунобіологічних препаратів ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» Олегу КОГУТУ забезпечити видачу імунобіологічних препаратів закладам охорони здоров'я Львівської області відповідно розподілу, затвердженого пунктом 1 даного наказу, з дотриманням холодового ланцюга та належною супровідною документацією.

3. Забезпечити фахівцями ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» транспортування ІБП та передачу до ЗОЗ з дотриманням холодового ланцюга та належною супровідною документацією.

4. Керівнику адміністративно – господарчого відділу Іванні ЖЕРНОВІЙ виділити машину-рефрижератор Citroen для розвезення ІБП згідно розроблених логістичних маршрутів;

5. Начальнику Управління охорони здоров'я м.Львова, відділу охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької міської ради, керівникам районних, міських закладів охорони здоров'я Львівської області, ЦПМСД, керівникам приватних медичних закладів, ФОПам, які визначені закладами-отримувачами МІБП відповідно до додатку 1 наказу ДОЗ ЛОДА від 31.01.2022 №68, забезпечити:

5.1. Надання належно оформленої довіреності на матеріально відповідальну посадову особу по роботі з МІБП, листа погодження згідно додатку 2 та акта приймання-передавання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного (форма акта наведена в додатку до Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 №595).

5.2. Дотримання умов «холодового ланцюга» на всіх етапах зберігання та використання МІБП.

5.3. Постійний контроль за раціональним використанням МІБП до завершення терміну їх придатності або повного використання.

5.4. Подачу щомісячно до 28 числа звітного місяця актів використання МІБП на паперових (за підписом керівника та печаткою установи) та електронних носіях на e-mail: lvivsescentr@gmail.com за формою, згідно додатків 3 та 4 цього наказу, відповідність даних щодо кількості використаних доз МІБП до звітної форми «Укрвак».

6. Контроль за виконанням наказу в межах повноважень покласти на заступника генерального директора з епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» Марію ОЗІРКОВСЬКУ.

Генеральний директор



Наталія ІВАНЧЕНКО

Розроблено :

Лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики
Завідувач складу МІБП



Ольга ГРЕСЬ
Олег КОГУТ

Погоджено:

Заступника генерального директора
з епіднагляду (спостереження) та
профілактики інфекційних хвороб
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»



Марія ОЗІРКОВСЬКА

Головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності



Оксана КОЦАН

Начальник відділу
правового забезпечення
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»



Лілія ХРИСТЕНКО

				Додаток до наказу ДОЗ від 11.03 -2023 № 29С-б	
ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	Тривалентна інактивована вірусна вакцина проти поліомієліту ІІІВ, серія 2309007А, термін придатності 14.02.2026, 1 доза у флаконі	Комбінована жива атенуйована вакцина проти кору, епідемічного паротиту і краснухи (КПК), серія Х008315, термін придатності 02.2025, 1 доза у флаконі	Вакцина проти дифтерії, правця та кашлюку АКДП, серія 2822Х010В, термін придатності 12.2024, 10 доз у флаконі		Шприци з автоматичним вимкненням (А-Д) 0,5 мл термін придатності 02.2027
ВСЬОГО:	Дози 2227	Дози 8367	Дози 460	Флакони 46	Штук 2687
Управління охорони здоров'я департаменту гуманітарної політики Львівської МР	500	2000	200	20	700
КНП Городецький ЦПМСД Городецької МР	10	30	0	0	10
КНП Жовківська лікарня Жовківської МР	400	1000	40	4	440
КНП Добросиньсько- Магерівський ЦПМСД Добросиньсько- Магерівської СР	0	30	0	0	0
КНП ЦПМСД Кам'янка- Бузької МР	50	100	0	0	50
КНП Новояричівська РЛ	0	460	0	0	0
КП Перемишлянська центральна РЛ	100	300	30	3	130
КНП ЦПМСД Бібрської МР	40	0	0	0	40
КНП Глинянська МЛ Глинянської МР	20	0	0	0	20
КНП ЦПМСД Давидівської СР	20	0	0	0	20
КНП ЦПМСД Зимноводівської СР	0	100	0	0	0
КНП Бродівська ЦМЛ Бродівської МР	0	200	0	0	0
КНП Бузької МР Буська ЦРЛ	0	150	0	0	0
КНП Золочівська ЦРЛ Золочівської МР	200	200	50	5	250
Місцеві охорони здоров'я виконавчих органів Дрогобицької МР	200	500	0	0	200
КНП ЦПМСД Східницької СР	20	0	0	0	20
КНП Центральна МЛ м. Борислава Бориславської МР	0	400	50	5	50
КНП Трускавецька МЛ Трускавецької МР	0	100	0	0	0
КНП ЦПМСД Біковицької сільської ради Самбірського району	20	10	0	0	20

КНП ЦПМСД Рудківської МР Самбірського району	0	70	0	0	0
КНП Добромилівської МР Добромилівська РЛ	50	50	0	0	50
КНП Турківський ЦПМСД Турківської МР	50	0	0	0	50
КНП Журавнівська МЛ Журавнівської СР	20	30	0	0	20
КНП ЦПМСД Розвадівської СР	0	20	0	0	0
КНП Сколівський ЦПМД Сколівської РР	20	30	40	4	60
КНП Славської СР Славська МЛ	0	50	0	0	0
КНП ЦПМСД м.Стрия	0	430	0	0	0
КНП Новороздільська МЛ Новороздільської МР	0	100	0	0	0
КНП Радохівська ЦРЛ Радохівської МР	20	100	0	0	20
КНП Сокальської РР Сокальська ЦРЛ	0	100	0	0	0
КП ЦПМСД м. Червонограда	0	200	50	5	50
КНП Яворівської РР Яворівська ЦРЛ	0	200	0	0	0
КНП Новояворівська лікарня імені Юрія Липи Новояворівської МР	200	200	0	0	200
КНП ЛОР Львівський обласний спеціалізований будинок дитини Любисток	0	5	0	0	0
КНП ЛОР Львівський обласний спеціалізований будинок дитини Мальви	0	10	0	0	0
КНП ЛОР "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"	50	0	0	0	50
КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний діагностичний центр"	0	25	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дитячий центр здоров'я"	0	200	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медікавер Україна"	0	60	0	0	0
Петрик Людмила Ярославівна	0	20	0	0	0
Пікулицька Ярина Василівна	50	0	0	0	50
Ходан Олена-Анастасія Андріївна	0	20	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мед Парк"	5	3	0	0	5

Яшишин Оксана Михайлівна	0	50	0	0	0
Апаріна Лідія Володимирівна	0	20	0	0	0
Марункевич Марія Володимирівна	0	40	0	0	0
Бунько Василь Михайлович	30	0	0	0	30
Лазаревич Петро Ярославович	0	50	0	0	0
Кравченко Романа Богданівна	100	200	0	0	100
Левкович Лідія Олексіївна	0	20	0	0	0
Ладус Галина Іванівна	0	20	0	0	0
Ярославівна	0	30	0	0	0
Козич Роксолана Андріївна	0	50	0	0	0
Салдан Іван Антонович	0	50	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю клініка сімейної медицини "БІХЕЛСІ"	20	200	0	0	20
Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична Зірка"	0	30	0	0	0
Товариство з обмеженою відповідальністю медичний центр "ОРА"	0	10	0	0	0
Симулик Марія Сергіївна	0	20	0	0	0
Люта Оксана Павлівна	2	6	0	0	2
Шкульський Володимир Володимирович	0	14	0	0	0
Гадєвич Наталія Зіновіївна	0	4	0	0	0
Ніконов Валерій Миколайович	30	50	0	0	30

Код ЄДРПОУ

№ _____

На № _____ від _____

Державна установа
«Львівський обласний центр
контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони
здоров'я України»
Генеральному директору
Наталії ІВАНЧЕНКО

Про погодження розподілу
імунобіологічних препаратів

Шановна Наталіє Олександрівно!

(КНП, ФОП, ТзОВ)..... висловлює Вам свою повагу та інформує про погодження розподілувакцини для профілактики в кількості доз та підтверджує, що поставлена вакцина буде використана в повному обсязі та використана до завершення терміну придатності.

З повагою,

Генеральний директор

.....

АКТ
списання виробничих запасів, матеріалів, медикаментів та
інших запасів, отриманих шляхом централізованого
постачання

станом на _____ 20__ року

(назва адміністративної території та установи, закладу)

№ з/п	Торговельна назва	Одиниці виміру	Серія	Ціна за од. (грн.)	Використано (кількість одиниць)	Використано (сума)
1	2	3	4	5	6	7

Керівник органу охорони здоров'я

підпис

Головний бухгалтер

підпис

Виконавець, ППБ, тел.

ІНФОРМАЦІЯ

про використання матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання

у 20__ році за станом на _____ 20__ року по
 закладу охорони здоров'я міста (району)

(установа, заклад)

Постачальник	КПКВ	Торгове льна назва	Наказ		Залишок на початок року		Отримано		Фактично використано		Залишок невикористан их препаратів	
			Дата	№	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума	Кіль кість	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник органу охорони здоров'я

підпис

Головний бухгалтер

підпис

Відповідний спеціаліст

підпис

виконавець, ПпБ, тел.

Certificate of Conformity / release notification

Certification by qualified person of Bilthoven Biologicals B.V. taking the overall responsibility for production and control of the medicinal product.

Name	Poliomyelitisvaccin
Marketing authorization no.	RVG 17642
Batch no.	2309007A
Manufacturing date	09-Feb-2023
Expiry date	14-Feb-2026

I herewith certify that the above indicated batch of medicinal product has been manufactured and tested according to the procedures approved by the competent authorities and complies with the quality requirements.

This includes that, for any materials derived from ruminants (bovine, ovine, caprine) used in the manufacture and/or formulation of the batch of product specified above, all measures have been taken to demonstrate compliance with Directive 2001/83EC and amending Directives 2003/63/EC and 2004/27/EC.

- ☒ The batch has been released for distribution on the Unicef market
- ☐ The batch has been released for distribution to a third party manufacturer in

Name	N.S.L. Vandekerckhove , pharmacist / Dr. J. Lodder, pharmacist
Function	Qualified Person
Date	11 MEI 2023
Signature	

ВАКЦИНА ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ
Листок-вкладиш: інструкція з медичного застосування

Термін придатності

Термін придатності складає 36 місяців.

Особливі застереження під час зберігання

Вакцину необхідно зберігати при температурі від 2 до 8°C. Не заморозувати.

Після відкриття багатодозового флакон (що містить 5 доз) зберігати при температурі від 2 до 8°C і використати протягом 28 днів.

Пакування

Вакцина розповсюджується у флаконі (гідролітичне скло типу 1), що закривається гумовою пробкою (без латексу) та алюмінієвим відкидним ковпачком, і містить 0,5 мл вакцини (однодозовий флакон) або 2,5 мл вакцини (багатодозовий флакон).

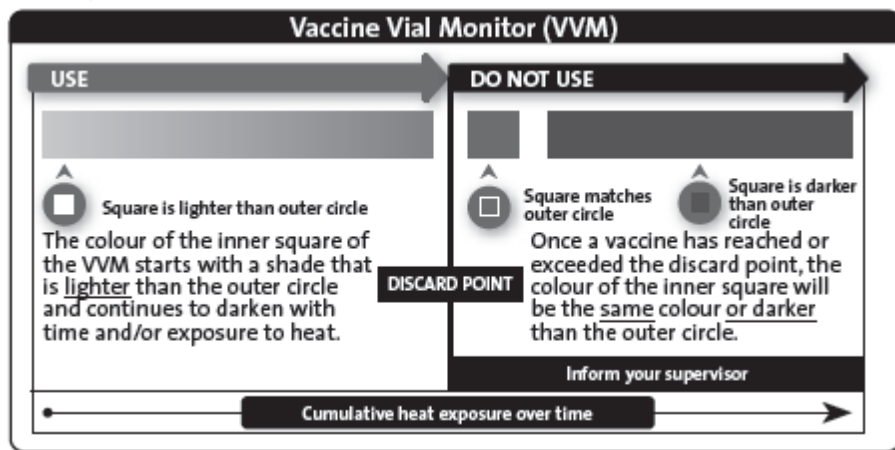
Особливі вказівки щодо використання та утилізації

Спеціальних вимог немає.

Флаконний термоіндикатор (за наявності):

Флаконний термоіндикатор (ФТІ) представлений на флаконі у вигляді кольорової точки. Це точка, чутлива до температури та часу, що вказує на сукупний тепловий вплив, здійснений на флакон. ФТІ попереджає кінцевого користувача, коли вплив тепла, ймовірно, призведе до погіршення ефективності та якості вакцини до неприйнятного рівня.

Інтерпретація ФТІ нескладна. Слід подивитися на квадрат по центру. Його колір буде поступово змінюватися. Вакцину можна використовувати, якщо колір цього квадрата світліший за колір кола. Щойно колір квадрата збігається з кольором кола або стає темнішим, флакон слід утилізувати.



Оригінал	Переклад
Use	Можна використовувати
Square is lighter than outer circle	Колір квадрату світліший за колір зовнішнього кола.
The color of the inner circle of the VVM begins with a shade that is <u>lighter</u> than the outer circle and continues to darken with time and/or exposure to heat.	Колір внутрішньої частини ФТІ починається з відтінку, який є <u>світлішим</u> за колір зовнішнього кола, він продовжує темніти з часом та/або під дією тепла.
Do not use	Не можна використовувати
Square matches circle	Колір квадрату такий самий, як і колір зовнішнього кола
Square is darker than circle	Колір квадрату темніший за колір зовнішнього кола
Discard point	Точка утилізації
Once a vaccine has reached or exceeded this discard point, the color of the inner circle will be the same color or darker than the outer circle.	Після того, як вакцина досягне або перевищить точку утилізації, колір внутрішньої частини буде таким самим або темнішим за колір зовнішнього кола.
Inform your supervisor	Проінформуйте свого керівника
Cumulative heat exposure over time	Сукупний вплив тепла з часом

ВЛАСНИК ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОДАЖ

Bilthoven Biologicals B.V. (Білтовен Біолоджикалз Б.В.)
Адреса: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9-13 3721 MA Bilthoven
The Netherlands (Нідерланди)
Телефон: +31 (0)30 8004800

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОДАЖ

Вакцина проти поліомієліту ліцензована в Нідерландах під номером RVG 17642
Багатодозова вакцина проти поліомієліту ліцензована в Нідерландах під номером RVG 114720

ДАНІ ВИДАЧІ ПЕРШОЇ ЛІЦЕНЗІЇ АБО ПОНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Перша ліцензія на одноразову вакцину видана 2 грудня 1993 року, поновлення ліцензії: 25 серпня 1994 року
Перша ліцензія на багатодозову вакцину (5 доз) видана 12 листопада 2014 року

РЕДАКЦІЯ

Редакція листка-вкладиша ВООЗ від серпня 2020 року

НАЗВА

Вакцина проти поліомієліту, суспензія для ін'єкцій

СКЛАД

Одна доза (0,5 мл) вакцини проти поліомієліту містить наступні активні компоненти:
Інактивовані вірус поліомієліту типу 1 (Mahoney)* 40 одиниць D-антигену
Інактивовані вірус поліомієліту типу 2 (MEF 1)* 8 одиниць D-антигену
Інактивовані вірус поліомієліту типу 3 (Saukett)* 32 одиниць D-антигену
Перелік допоміжних речовин див. у розділі фармацевтичних даних.

*) Культивовані в культурі клітин Vero.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ СКЛАД

Суспензія для ін'єкцій. Препарат представлений у вигляді суспензії інактивованого та очищеного формальдегідом вірусу в одноразовому або багатодозовому (5 доз) флаконі. Колір вакцини варіює від оранжево-жовтого до оранжево-червоного.

КЛІНІЧНІ ДАНІ

Терапевтичні показання

Активна імунізація проти поліомієліту.

Спосіб застосування та дози

Одна доза становить 0,5 мл як для дітей, так і для дорослих. Вакцину вводять підшкірно або внутрішньом'язово. Перша серія імунізації складається з трьох щеплень, які проводяться з мінімальним інтервалом у 4 тижні. Немовлята повинні отримати першу серію протягом перших 6 місяців життя. Після завершення першої серії імунізації бустерну дозу можна вводити не менше ніж через шість місяців. Якщо місцеві органи влади рекомендують графік вакцинації, який починається у віці від 2 місяців, та/або якщо інтервал між дозами становить менше 8 тижнів, бустерну дозу слід вводити не раніше ніж у 9 місяців. Цю вакцину необхідно використовувати відповідно до чинних національних рекомендацій та згідно з рекомендаціями ВООЗ. Особам, які повністю імунізовані проти поліомієліту та виїжджають до районів з високим рівнем захворюваності на поліомієліт, рекомендується повторна вакцинація однією дозою вакцини проти поліомієліту приблизно за 1 місяць до від'їзду, особливо якщо остання вакцинація відбувалася понад 15 років тому.

Протипоказання

Загальні протипоказання, що застосовуються до кожної вакцини:

- Попередня тяжка реакція після щеплення цією ж вакциною.
- Відома гіперчутливість до одного або кількох компонентів вакцини.
- Не вводити, якщо вакцинований страждає від тяжкої інфекції, що супроводжується лихоманкою.

Запобіжні заходи перед введенням вакцини

Колір вакцини може варіювати від оранжево-жовтого до оранжево-червоного. Не можна використовувати вакцину з яскраво жовтим або фіолетовим забарвленням. Не вводити, якщо вакцинований страждає від тяжкої інфекції, що супроводжується лихоманкою. Діти старшого віку і дорослі після щеплення можуть знепритомніти. Зазвичай це відбувається незабаром після щеплення і може виникнути одночасно з нудотою та блювотою. Якщо під час попередніх щеплень виникала непритомність або спостерігалися симптоми, що вказують на непритомність, людину слід вакцинувати в положенні сидячи або лежачи. За жодних обставин не вводити вакцину проти поліомієліту внутрішньосудинно. Як і під час вакцинації будь-якою вакциною, необхідно забезпечити адекватне лікування на випадок, якщо після вакцинації виникне анафілактична реакція. За потреби можна зробити ін'єкції епінефрину або кортикостероїдів у дозі відповідно до віку та/або маси тіла. Особи, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як безсимптомні, так і ті, в яких є симптоми, повинні бути імунізовані інактивованою вакциною проти поліомієліту згідно зі стандартними графіками. Якщо вакцина проти поліомієліту вводиться особам з імунодефіцитом або тим, хто проходить будь-який тип імуносупресивної терапії, очікувана імунна відповідь може не відбутися. Потенційний ризик розвитку апное та необхідність респіраторного моніторингу протягом 48-72 годин слід враховувати при проведенні першої серії імунізації для дуже недоношених немовлят (народжені на ≤ 28 тижні вагітності), особливо з незрілою дихальною системою в анамнезі. Оскільки користь від вакцинації є високою для цієї групи немовлят, не слід відкладати вакцинацію.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші форми взаємодії

Вакцину проти поліомієліту можна вводити одночасно з іншими вакцинами в різні місця введення.

Вагітність та грудне вигодовування

Дані щодо великої кількості вакцинованих вагітних вказують на відсутність негативного впливу вакцини проти поліомієліту на вагітність або здоров'я плода/новонародженої дитини. Однак вакцину проти поліомієліту слід застосовувати під час вагітності лише за наявності явного ризику інфікування. Вакцину проти поліомієліту можна використовувати в період грудного вигодовування.

Вплив на навички водіння або здатності керувати механізмами

Малоймовірно, що вакцина проти поліомієліту впливає на навички водіння або керування механізмами.

Несприятливі реакції

На підставі постмаркетингової інформації (добровільне повідомлення) було встановлено, що можливі наступні несприятливі реакції. Несприятливі події після імунізації вакциною проти поліомієліту, про які повідомляли, здебільшого виникали протягом перших трьох днів після вакцинації та мали тимчасовий характер.

Загальні розлади та реакції:

Місцеві реакції:

Рідко (>1/10 000, <1/1 000): Набряк, почервоніння та біль у місці введення вакцини.

Системні реакції:

Рідко (>1/10 000, <1/1 000): Лихоманка, дискомфорт.

Неврологічні розлади:

Дуже рідко (< 1/10.000): (Полі-) нейропатія.

Дихальні, торакальні та середостінні розлади:

Апное дуже недоношених немовлят (народжені на ≤ 28 тижні вагітності).

Передозування

Про випадки передозування не повідомлялося.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Фармакодинамічні аспекти

Фармакотерапевтична група: Вірусні вакцини, код АТХ: J07BF03.

У тварин (мавп або шурів) введення вакцини призводить до утворення нейтралізуючих антитіл.

Введення вакцини у людини призводить до утворення антитіл та імунологічної пам'яті. Введення другої дози вакцини призводить до вторинної відповіді, що характеризується швидким підвищенням рівня антитіл, що вказує на наявність імунологічної пам'яті.

Загалом рівень антитіл є показником захисту. Для поліомієліту титр (реципрокне розведення в аналізі нейтралізації) ≥ 8 є захисним. Проходження повної серії імунізації вакциною проти поліомієліту, як правило, забезпечує захисні титри проти поліомієліту типу 1, 2 і 3.

Відсоток серопротекції в загальній популяції Нідерландів вивчався в 1995-1996 рр. (Immunity to Poliomyelitis in the Netherlands, Am.J.Epid., 2001:153,3). Протягом десяти років, що передували цьому дослідженню, рівень вакцинації в рамках первинної імунізації комбінованою вакциною для профілактики дифтерії, правця, кашлюка та поліомієліту (DTP-IPV) (3 дози з інтервалом через 3, 4 і 5 місяців) національної програми імунізації Нідерландів становив 97%. Вік обстежених коливався від 1 до 79 років. Рівень серопротекції може залежати від моменту забору зразків крові після вакцинації, який не був, як у більшості клінічних досліджень, через 1 місяць після вакцинації. Інтервал забору зразків крові після вакцинації змінювався залежно від віку людини.

Крім того, слід зазначити, що дані отримані як після використання звичайної вакцини проти поліомієліту, так і після використання комбінованої вакцини з компонентом проти поліомієліту. Відсоток серопротекції, виміряний у цьому дослідженні, наведено в наступній таблиці.

	серопротекція	95% довірчий інтервал
Поліомієліт типу 1	96,6 %	95,9 – 97,2 %
Поліомієліт типу 2	93,4 %	92,3 – 94,5 %
Поліомієліт типу 3	89,7 %	88,3 – 91,0 %

Фармакокінетика

Не застосовується для вакцин.

Доклінічні дослідження безпеки

Доклінічні дослідження не демонструють особливого ризику для людини. Ці результати отримані в рамках звичайних досліджень в області фармакологічної безпеки та токсикології при повторному введенні.

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ДАНІ**Перелік допоміжних речовин**

Формальдегід (12,5 мкг) (E240), 2-феноксіетанол (2,5 мг), середовище 199, яке в основному складається з амінокислот, мінералів і вітамінів (0,1 мл), динатрію гідрофосфату дегідрат (E339), калію хлорид (E508), натрію хлорид, дигідрофосфат калію (E340), полісорбат 80 (E433), кальцію хлорид (E509), феноловий червоний та вода для ін'єкцій.

Випадки несумісності

Не застосовується.

Пробний макет	
УВАГА! Нам потрібне погодження макету, перш ніж ми зможемо розпочати виробництво. Будь ласка, розбірливо заповніть цю форму.	
Дата:	24.08.2020
№ замовлення:	388406
Код продукту:	200459 IPV 1d-5d ENG WHO
Артикул «Dobber Healthcare Leaflets BV.»: S00636	
Розмір:	168 x 160 мм
У складеному стані:	83(+2) x 20 мм
Колір(и) друку	Чорний/PMS 186
Лицьова сторона:	Чорний
Зворотна сторона:	Чорний
Квадрат (перехід):	-
Оптичний код:	-
Фармацевтичний код:	200459
Шрифт:	The Sans
Розмір шрифту:	6 pt
Міжрядковий інтервал:	8 pt
DOBBER HEALTHCARE LEAFLETS Dobber Healthcare Leaflets BV Адреса: Westerwerf 13 1911 JA Uitgeest Телефон: +31 (0)251 31 19 50 E-mail: info@dobberpharma.com www.dobberhealthcare.com	
Заповнюється клієнтом	
Kwaliteit Duurzaamheid ISO 9001 ISO 14001	
Погоджено: ☐ TAK ☐ NI	
Дата:	
Ім'я та підпис:	
(Ця форма належить SOP "Werkzaamheden DTP-Studio").	

Сертифікат аналізу / відповідності

MERCK SHARP & DOHME B.V. (Мерк Шарп і Доме Б.В.)

WAARDERWEG 39, 2031 BN HAARLEM THE NETHERLANDS (ВААРДЕРВЕГ 39, 2031 БН ХАРЛЕМ НІДЕРЛАНДИ)

Прийняття рішення:

Прийнято

B. Aolad-si Mhammad
(Б. Аолад-сі Мхаммад)
КВАЛІФІКОВАНА ОСОБА

05-КВІТНЯ-2023 р. час: 10:08:44 EST

Електронний підпис

Серія номер	X008315
Номер серії на первинній упаковці	0001455711
Матеріал	1036837
Номер продукції	4953
Опис лікарського засобу	ОДНОДОЗОВИЙ ФЛАКОН ВАКЦИНИ М-М-РВАКСПРО (для одночасної вакцинації проти кору, паротиту та краснухи) + 1 попередньо наповнений шприц з розчинником (вода для ін'єкцій)
Дата виробництва	22-БЕРЕЗНЯ-2023
Термін придатності	лютий 2025 року

Затверджено за дорученням Виконавчого директора Офіс якості / кваліфікованої особи
Катрін Абеляйн (Kathrin Abelein) – Мерк Шарп і Доме Б.В., Харлем, Нідерланди

Характеристика	Специфікація	Результат	Пройшов/не пройшов перевірку
Стерильність	Не спостерігається ріст мікроорганізмів	Відповідає	ПРОЙШОВ
пройшов	Ліофілізована, світло-жовтого кольору (темно-жовтий колір неприйнятний), компактна кристалічна маса	Відповідає	ПРОЙШОВ
Ідентифікаційна характеристика: Кір (культура тканини)	Мінімум 90-відсоткове зниження типового цитопатичного ефекту при використанні гомологічної антисироватки	Відповідає	ПРОЙШОВ
Ідентифікаційна характеристика: Паротит (культура тканин)	Мінімум 90-відсоткове зниження типового цитопатичного ефекту при використанні гомологічної антисироватки	Відповідає	ПРОЙШОВ
Ідентифікаційна характеристика: Краснуха (культура тканин)	Мінімум 90-відсоткове зниження типового цитопатичного ефекту при використанні гомологічної антисироватки	Відповідає	ПРОЙШОВ
Вологість (%)	Максимум 3.0%	0.7 %	ПРОЙШОВ

Сертифікат аналізу / відповідності

MERCK SHARP & DOHME B.V. (Мерк Шарп і Доме Б.В.)

WAARDERWEG 39, 2031 BN HAARLEM THE NETHERLANDS (ВААРДЕРВЕГ 39, 2031 БН ХАРЛЕМ НІДЕРЛАНДИ)

Показник pH	6.2 - 6.8	6.5	ПРОЙШОВ
Відновлення (секунди)	Максимум 120 секунд	5 с	ПРОЙШОВ
Титрування інфекційності: Кір (підрахунок)	від 3,8 до 4,2-log10 TCID 50(інфекційна доза 50% культури тканин)/доза, калібровано	4.1 ЦПД/Доза	ПРОЙШОВ
Титрування інфекційності: Паротит (підрахунок)	від 5.0 до 5.5-log10 TCID 50(інфекційна доза 50% культури тканин)/доза, калібровано	5.3 ЦПД/Доза	ПРОЙШОВ
Титрування інфекційності: Краснуха (підрахунок)	від 3.4 до 4.1-log10 TCID 50(інфекційна доза 50% культури тканин)/доза, калібровано	4.0 ЦПД/Доза	ПРОЙШОВ
Аналіз: бичачий сироватковий альбумін (нг/доза)	Максимальна одноразова доза 50 нг для людини	4 нг/Доза	ПРОЙШОВ
Термостійкість	Максимальна різниця між середніми геометричними титрами інкубованих і неінкубованих зразків становить 1,0 log. Немає вимог щодо дотримання мінімального титру вивільнення після вирощування мікроорганізмів	Відповідність	ПРОЙШОВ
Час тримання поза холододовим ланцюгом при виробництві	Максимум 720 хвилин	469 хвилин	ПРОЙШОВ

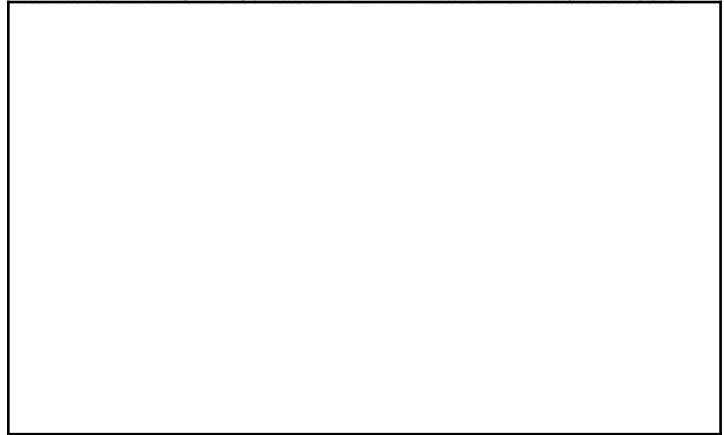
* TCID – ЦПД (цитопатична доза)

Сертифікат аналізу / відповідності

MERCK SHARP & DOHME B.V. (Мерк Шарп і Доме Б.В.)

WAARDERWEG 39, 2031 BN HAARLEM THE NETHERLANDS (ВААРДЕРВЕГ 39, 2031 БН ХАРЛЕМ НІДЕРЛАНДИ)

Номер серії 008315
Номер серії на первинній упаковці 0001455711
Матеріал 1036837
Продукція номер 4953
Опис лікарського засобу ОДНОДОЗОВИЙ ФЛАКОН
 ВАКЦИНИ М-М-РВАКСПРО
 (для одночасної вакцинації проти
 кору, паротиту та краснухи) + 1
 попередньо наповнений шприц з
 розчинником (вода для ін'єкцій)
Дата виробництва 22-БЕРЕЗНЯ-2023 р.
Термін придатності лютий 2025 року



Затверджено за дорученням Виконавчого директора Офіс якості / кваліфікованої
 особи
 Катрін Абеляйн (Kathrin Abelein) – Мерк Шарп і Доме Б.В., Харлем, Нідерланди

Характеристика	Специфікація	Результат	Пройшов/не пройшов перевірку
Час тримання поза холодним ланцюгом при пакуванні	Максимум 840 хвилин	622 хвилин	ПРОЙШОВ
Час тримання поза холодним ланцюгом при транспортуванні	Максимум 120 хвилин	120 хвилин	ПРОЙШОВ
Загальний час без охолодження	Максимум 1680 хвилин	1211 хвилин	

Цим я засвідчую, що наведена вище інформація є достовірною та точною. Дану партію препарату, включаючи проміжні продукти та активну(і) фармацевтичну(і) речовину(и), було виготовлено, включаючи пакування/маркування та контроль якості, на вищезазначеному(их) підприємстві(ях) у повній відповідності до вимог щодо Правил належної виробничої практики (GMP) місцевого регуляторного органу, а також специфікацій та вимог, зазначених у реєстраційному посвідченні на лікарський засіб країни-імпортера. Записи щодо виробництва, пакування та аналізу партії лікарського засобу було перевірено та визнано такими, що відповідають вимогам діючих Правил належної виробничої практики. Звітні результати отримані безпосередньо після виробництва партії продукції. У разі проведення випробувань при ввезенні, ці результати відображаються в окремому Сертифікаті аналізу тестування при ввезенні, який надається разом з цим Сертифікатом. Партію було випущено відповідно до Директиви ЄС 2001/83/ЄС. У цьому Сертифікаті аналізу зазначено специфікації випуску партії препарату.

	Номер Реєстраційного посвідчення виробника	Сертифікат/еквівалентна уніфікована доза №
Сайт пакування продукції	Компанія «MSD B.V. Нідерланди», ХАРЛЕМ, НІДЕРЛАНДИ	108958 F NL/H 21/2035427A
Сайти первинного пакування	Компанія з обмеженою відповідальністю «МЕРК ШАРП І ДОМЕ ЛЛС», м.ДАРЕМ, ПІВНІЧНА КАРОЛІНА, США (MERCK SHARP & DOHME LLC, DURHAM NC, US)	
Сайти масового виробництва	Компанія з обмеженою відповідальністю «Мерк Шарп і Доме ЛЛС», м.Дарем, Північна Кароліна, США	

Сертифікат аналізу / відповідності

MERCK SHARP & DOHME B.V. (Мерк Шарп і Доме Б.В.)

WAARDERWEG 39, 2031 BN HAARLEM THE NETHERLANDS (ВААРДЕРВЕГ 39, 2031 БН ХАРЛЕМ НІДЕРЛАНДИ)

(Merck Sharp & Dohme LLC, Durham, US)

Сайт випускуКомпанія «MSD B.V. Нідерланди», ХАРЛЕМ,
НІДЕРЛАНДИ

108958 F

NL/H 21/2035427A

(MSD B.V. Netherlands, HAARLEM, NL)

**Сайт тестування продукції
на імпорт**Компанія «MSD B.V. Нідерланди», ХАРЛЕМ,
НІДЕРЛАНДИ

(MSD B.V. Netherlands, HAARLEM, NL)

Номер реєстраційного посвідчення

Королівство Бельгії (BE)

EU/1/06/337/011

Люксембург (LU)

EU/1/06/337/011

Нідерланди (NL)

EU/1/06/337/011

Від
бит
ки
штр
их-
код
у
100
мм
@
100
%

MSD ARTWORK

Item No.70003054

MSD Item No. (EOM)N/A

Revision Info & No.000222-1

Plant Code108020

Job/Work Job No.400725409-0000

ADP/N/A





SGK™

Proprietary



100% 50% 25% 0%

MSD-Dr. Design Werkstatt
Bismarckstr. 17
40699 Düsseldorf
Germany

ПАРАМЕТРИ ТА ДАНІ ТЕКСТУ ЛИСТІВКИ-ВКЛАДИША	
Еількість знаків і пробілів	20781
Кількість слів	3032
Кількість рядків	323
Вільне місце	0% - -5 рядків
Розмір шрифту тексту	8pt
Масштабування основного тексту	100%
Тип фонту	NimbusSanLOT

К-П-К® II
(ЖИВА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ) СУСПЕНЗІЯ ДЛЯ ПІДСКІРНОГО ВВЕДЕННЯ
ПОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. ПОКАЗАЗАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
КПК (М-М-Р® II) - це вакцина, показана для активної імунізації з метою профілактики кору, паротиту та краснухи у дітей віком від 12 місяців і старше.

2. ДОЗУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Тільки для підскірного застосування
Доза та графік введення
Кожну дозу об'ємом 0,5 мл вводять підшкірно.
Перша доза вводиться у віці від 12 до 15 місяців. Другу дозу вводять у віці від 4 до 6 років.

Другу дозу можна вводити до 4 років за умови, що між щепленнями дозами живої вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи має бути мінімальний інтервал в один місяць.

Діти, які отримали першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи до свого першого дня народження, повинні отримати додаткові дози вакцини у віці 12-15 місяців та у віці 4-6 років для завершення серії вакцинації [див. розділ «Клінічні дослідження» (14.2)].

Для постконтактної профілактики кору введіть дозу вакцини КПК II протягом 72 годин після контакту.

2.2. Підготовка та введення вакцини

Для кожної ін'єкції та/або відновлення (розчинення) вакцини використовуйте стерильний шприц, що не містить консервантів, антисептиків та миючих засобів, оскільки ці речовини можуть інактивувати живу вірусну вакцину. Для відновлення вакцини використовуйте лише розчинник, що постачається разом з вакциною, оскільки він не містить консервантів або інших противірусних речовин, які можуть інактивувати вакцину.

Витягніть весь об'єм розчинника з флакона та введіть у флакон з ліофілізованою вакциною. Перемішайте до повного розчинення. Ліофілізовану вакцину слід утилізувати, якщо її неможливо розчинити.

Витягнуті весь об'єм відновленої вакцини та ввести підшкірно в місці зовнішньої частини плеча (ділянка дельтоподібного м'яза) або у верхню передньо-латеральну ділянку стегна.

Перед введенням парентеральні лікарські засоби слід візуально перевірити на наявність твердих частинок та зміну кольору, якщо це дозволяють ризич та контейнер. Здійснити візуальний огляд вакцини до та після розчинення перед її введенням. Перед розчиненням ліофілізована вакцина має вигляд світло-жовтої компактної кристалічної маси, а після відновлення - являє собою прозору жовту рідину. Якщо ви спостерігаєте у відновленій вакцині наявність твердих частинок або зміну кольору, вакцину необхідно утилізувати.

Щоб мінімізувати втрату ефективності, вакцину КПК II слід вводити якомога швидше після відновлення. Якщо не використати вакцину негайно, відновлену вакцину можна зберігати за температури від 2°C до 8°C, в захищеному від світла місці, до 8 годин. Слід утилізувати відновлену вакцину, якщо її не було використано протягом 8 годин.

3. ЛІКАРСЬКІ ФОРМИ ТА ПЕРЕВАГИ

Вакцина КПК II - це суспензія для ін'єкцій, що постачається у вигляді однодозового флакону з ліофілізованою вакциною, яку необхідно відновити за допомогою стерильного розчинника, що додається [див. розділи «Спосіб застосування та дози» (2.2) та «Спосіб постачання/зберігання та поводження з препаратом» (16)]. Разова доза після розчинення становить 0,5 мл.

4. ПРОТИПОКАЗАЗАННЯ

4.1. Підвищена чутливість

Не вводити вакцину КПК II особам, які мають в анамнезі підвищену чутливість до будь-якого компонента вакцини (включаючи желатин) або у яких спостерігалася реакція гіперчутливості після введення попередньої дози вакцини КПК II або будь-якої іншої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Не вводити вакцину КПК II особам, які в анамнезі мали анафілаксію до неоміцину [див. розділ «Опис» (11)].

4.2. Імуносупресія

Не вводити вакцину КПК II особам з імунодефіцитом або імуносупресією внаслідок захворювання або медикаментозної терапії. Повідомлялося про випадки енцефаліту, викликаного тільцями кору (МІВЕ), пневмоніту та смерті як прямого наслідку дисемінованої інфекції, спричиненої вірусом кору, серед осіб з ослабленим імунітетом, які були випадково щеплені вакциною проти кору. У цій популяції також були зареєстровані випадки дисемінованої інфекції вірусу паротиту та краснухи.

4.3. Помірне або тяжке гарячкове захворювання

Не вводити вакцину КПК II особам з активним гарячковим захворюванням за температурою > 38,5°C.

4.4. Непликований туберкульоз активної форми

Не вводити вакцину КПК II особам з непликованим туберкульозом (ТБ) активної форми.

4.5. Вагітність

Не призначати щеплення вакциною КПК II вагітним жінкам або тим, хто планує завагітніти протягом наступного місяця [див. «Застосування в окремих групах населення» (8.1) та «Інформація для пацієнта» (17)].

5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

5.1. Фебрильні судоми

Існує ризик виникнення гарячки та пов'язаних з нею фебрильних судом у перші 2 тижні після імунізації вакциною КПК. У дітей, які раніше перенесли фебрильні судоми (з будь-якої причини), а також у дітей з фебрильними судомами в сімейному анамнезі існує невелике підвищення ризику виникнення фебрильних судом після отримання вакцини КПК [див. розділ «Побічні реакції» (6)].

5.2. Підвищена чутливість до яєць

Особи, які в анамнезі мають анафілактичні, анафілактоїдні чи інші миттєві реакції (наприклад, кропив'янка, набряк рота і горла, утруднене дихання, гіпотензія або шок) після вживання яєць можуть мати підвищений ризик розвитку миттєвих реакцій підвищеної чутливості після введення вакцини КПК II. Перед тим, як розглядати можливість вакцинації таких осіб, необхідно оцінити потенційні ризики та відомі переваги.

5.3. Тромбоцитопенія

Повідомлялося про транзиторну тромбоцитопенію протягом 4-6 тижнів після щеплення вакциною для профілактики кору, паротиту та краснухи. Ретельно оцініть потенційний ризик і користь вакцинації у дітей з тромбоцитопенією або у тих, у кого спостерігалася тромбоцитопенія після вакцинації попередньою дозою вакцини проти кору, паротиту та краснухи [див. розділ «Побічні реакції» (6)].

5.4. Імунодефіцит в сімейному анамнезі

Вакцинацію осіб із вродженим або спадковим імунодефіцитом у сімейному анамнезі необхідно відкласти доки не буде проведено оцінку імунного статусу особи та не буде встановлено, що вони є імункомпетентними.

5.5. Імуноглобуліни та переливання крові

Імуноглобуліни (IG) та інші препарати крові не слід вводити одночасно з вакциною КПК II [див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами» (7.2)]. Ці препарати можуть містити антитіла, які перешкоджають реплікації вакцинного вірусу і знижують очікувану імунну відповідь.

Консультативний комітет з практики імунізації (ACIP) має конкретні рекомендації щодо інтервалів між введенням препаратів, що містять антитіла, а також вакцин, які містять живий вірус.

6. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Нижчезазначені побічні реакції включають ті, що були виявлені під час клінічних досліджень або про які повідомлялося під час застосування вакцини КПК II або її окремих компонентів після схвалення.

Організм в цілому

Панікуліт; атиповий кір; гарячка; непитомість; головний біль; запаморочення; нездужання; дратівливість.

Серцево-судинна система

Васкуліт.

Система органів травлення

Панкреатит; діарея; блювання; паротит; нудота.

Гематологічна та лімфатична системи

Тромбоцитопенія; пурпура; регіонарна лімфаденопатія; лейкоцитоз.

Імунна система

Анафілаксія, анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк (в тому числі периферичний набряк або набряк обличчя) та бронхіальний спазм.

Опорно-рухова система

Артрит; артралгія; міалгія.

Нервова система

Енцефаліт; енцефалопатія; енцефаліт з включенням тільць кору (МІВЕ); підострий склерозуючий паненцефаліт (SSPE); синдром Гієна-Барре (GBS); гострий розсіяний енцефаломієліт (ADEM); попереочний мієліт; фебрильні судоми; фебрильні судоми або напади; атаксія; поліневрит; полінейропатія; очні паралічі; парестезії

Система органів дихання

Пневмонія; пневмоніт; біль у горлі; кашель; риніт.

Шкіра

Синдром Стивенса-Джонсона; гострий геморагічний набряк немовлят; пурпура Еноха-Шенлейна; багаточисленна ексудативна еритема; кропив'янка; висип; кіроподібний висип; свербеж; реакції у місці введення ін'єкції (біль, еритема, набряк та везикуляція).

Спеціальні органи сприйняття - органи слуху

Глухота, пов'язана з ураженням слухового нерва; отит середнього

вуха.

Спеціальні органи сприйняття - органи зору

Ретиніт; неврит зорового нерва; паліліт; кон'юнктивіт.

Сечостатева система

Епідідиміт; орхіт

7. ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

7.1. Кортикостероїди та імуносупресивні препарати

Вакцину КПК II не слід вводити особам, які отримують імуносупресивну терапію, в тому числі високі дози кортикостероїдів. Щеплення осіб, які приймають імуносупресивні препарати, вакциною КПК II може призвести до дисемінованого захворювання, спричиненого вакциною проти кору [див. розділ «Противопоказання» (4.2)].

7.2. Імуноглобуліни та переливання крові

Введення імуноглобулінів та інших препаратів крові одночасно з вакциною КПК II може вплинути на очікувану імунну відповідь [див. розділ «Застереження та запобіжні заходи» (5.5)]. Консультативний комітет щодо практики імунізації надає конкретні рекомендації стосовно інтервалів між введенням препаратів, що містять антитіла, а також вакцин, що містять живий вірус.

7.3. Шкірна туберкульозна проба

Є дані про те, що живі атенуовані вакцини проти вірусу кору, епідемічного паротиту та краснухи, введені окремо, можуть спричинити тимчасове пригнічення шкірної чутливості до туберкульозу. Тому, якщо необхідно зробити шкірну туберкульову пробу з використанням туберкульну (очищене похідне білка), її слід проводити до, одночасно з або принаймні через 4-6 тижнів після щеплення вакциною КПК II.

7.4. Застосування з іншими вакцинами, що містять живий вірус

Вакцину КПК II можна вводити одночасно з іншими вакцинами, що містять живий вірус. Якщо вакцина КПК II не вводяться одночасно з іншими, її слід вводити за місяць до або через місяць після введення інших живих вірусних вакцин, щоб уникнути потенційної імунної інтерференції.

8. ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

8.1. Вагітність

Стислий опис ризиків

Противопоказано застосовувати вакцину КПК II для вагітних жінок, оскільки інфікування під час вагітності вірусами дикого типу було пов'язано з несприятливими наслідками для матері та плода.

Після інфікування диким типом кору під час вагітності спостерігається підвищена частота спонтанних абортів, випадків мертвородження, передчасних пологів та вроджених вад розвитку. Інфікування диким паротитом під час першого триместру вагітності може збільшити частоту спонтанних абортів.

Зараження краснухою дикого типу під час вагітності може призвести до викидня або мертвородження. Якщо інфікування краснухою відбувається під час першого триместру вагітності, це може призвести до тяжких вроджених дефектів - синдрому вродженої краснухи (СВК). Синдром вродженої краснухи у немовлят включає, зокрема, прояви з боку органів зору (катаракта, глаукома, ретиніт), вроджені вади серця, порушення слуху, мікроцефалію та затримка розумового розвитку. Вакцина КПК II містить живі ослаблені віруси кору, паротиту та краснухи. Невідомо, чи може вакцина КПК II завдати шкоди плоду при її введенні вагітним жінкам. Адекватних і добре контрольованих досліджень застосування вакцини КПК II для вагітних жінок немає.

Будь-яка вагітність має ризики вроджених вад, втрат або інших несприятливих наслідків. У загальній популяції США фонові ризики розвитку серйозних вроджених вад та викиднів при клінічно діагностованій вагітності оцінюються від 2% до 4% і від 15% до 20%, відповідно.

Наявні дані свідчать про те, що частота серйозних вроджених вад розвитку та викиднів у жінок, які отримали вакцину КПК II протягом 30 днів до вагітності або під час вагітності, відповідає розрахунковим фоновим показникам (див. розділ «Дані»).

Дані

Клінічні дані

У результаті сукупного аналізу постмаркетингових звітів щодо вакцини КПК II за період з моменту отримання ліцензії 01 квітня 1978 року до 31 грудня 2018 року було виявлено 796 повідомлень про ненавмисне введення вакцини КПК II за 30 днів до або в будь-який час під час вагітності з відомими наслідками для вагітності. Із числа проспективно спостережуваних вагітних, для яких були відомі терміни щеплення вакциною КПК II, 425 жінок отримали вакцину КПК II протягом 30 днів до зачаття і протягом другого триместру вагітності. Результати проспективного дослідження за 425 вагітними жінками включали 16 немовлят з серйозними вродженими вадами розвитку, 4 випадки внутрішньоутробної смерті та 50 випадків викиднів. У пацієнток, які отримали вакцину КПК II, не було виявлено жодних аномалій, сумісних з синдромом вродженої краснухи. Вакциний вірус краснухи може проникати через плаценту, що призводить до безсимптомного інфікування плоду. Доведено, що вірус епідемічного паротиту також проникає через плаценту, але немає доказів того, що він викликає вроджені вади розвитку або захворювання у плода або немовлят.

CDC створив Реєстр вакцинації вагітних жінок (1971-1989 рр.), які отримали вакцину для профілактики краснухи протягом 3 місяців до або після зачаття. Дані про 1221 випадково вакциновану вагітну жінку не продемонстрували жодних ознак збільшення аномалій розвитку плоду або випадків синдрому вродженої краснухи (СВК) у жінок, включених до реєстру.

8.2. Лактація

Стислий опис ризиків

Невідомо, чи виділяється вакцинний вірус кору або паротиту в материнське молоко. Дослідження показали, що жінки, які вигодовують грудьми і вакциновані живою ослабленою вакциною проти краснухи, можуть виділяти вірус з грудним молоком і передавати його немовлятам, які перебувають на грудному вигодовуванні. У немовлят, які перебували на грудному вигодовуванні з серологічним підтвердженням наявності антитіл до вакцинного штаму вірусу краснухи, жодна дитина не мала тяжкого перебігу захворювання, проте в одній дитині спостерігалася легка клінічна картина, характерна для набутіт краснухи.

При цьому необхідно враховувати переваги грудного вигодовування для розвитку та здоров'я дитини, а також клінічну потребу матері у введенні вакцини КПК II та будь-якій потенційній несприятливій наслідки для дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, внаслідок застосування вакцини КПК II або основного захворювання матері. Для профілактичної вакцинації матері основною умовою є сприйнятливість до вакцино-керованого захворювання.

8.4. Використання в педіатрії

Вакцина КПК II не схвалена для осіб віком до 12 місяців. Дані щодо безпеки та ефективності вакцини проти кору для немовлят віком до 6 місяців не встановлено [див. розділ «Клінічні дослідження» (14)]. Безпеку та ефективність застосування вакцини проти епідемічного паротиту та краснухи для дітей віком до 12 місяців не встановлено.

8.5. Застосування вакцини для осіб похилого віку

Клінічні дослідження застосування вакцини КПК II не включали достатню кількість серонегативних пацієнтів віком від 65 років і старше, щоб ми могли визначити, чи відрізняється їхня реакція від реакції молодших пацієнтів.

11 ОПИС

Вакцина КПК II - це стерильний ліофілізований препарат (1) живої вірусної вакцини проти кору, атенуованої лінії вірусу кору, отриманої з атенуованого штаму Едмонстон Ендерса і розмноженої в культурі клітин курячого ембріона; (2) живої вірусної вакцини проти паротиту, штаму Jeryl Lypnt (рівень В) вірусу паротиту, розмноженої у культурі клітин курячого ембріона; та (3) живої вірусної вакцини проти краснухи, штаму Wistar RA 27/3 живого атенуованого вірусу краснухи, розмноженої у диплоїдних фібробластах легень людини WI-38. Клітини, пули вірусів, рекомбінантний людський сироватковий альбумін та фетальну бичачу сироватку, які використовують при виробництві, тестуються та визнаються такими, що не містять сторонніх агентів.

Після розчинення кожна доза об'ємом 0,5 мл містить не менше 3,0 log₁₀ TCID₅₀ (інфекційна доз культури тканини) вірусу кору; 4,1 log₁₀ TCID₅₀ вірусу епідемічного паротиту; та 3,0 log₁₀ TCID₅₀ вірусу краснухи.

Розраховано, що кожна доза містить сорбіт (14,5 мг), сахарозу (1,9 мг), гідролізовану желатину (14,5 мг), рекомбінантний людський альбумін (<0,3 мг), ембріональну бичачу сироватку (<1 ppm) та приблизно 25 мкг неоміцину. Препарат не містить консервантів.

Кожна доза також містить нелікарські інгредієнти: середовище 199 з солями Хенка; мінімальне збагачене середовище Гаррі Ігла; моногідрат L-глутамату натрію; феноловий червоний, двохоносовий фосфат калію,

Натрій Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль натрію (23 міліграми) на дозу, тобто практично не містить натрію. Калій Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль калію (39 міліграмів) на дозу, тобто практично не містить калію. Сорбіт (Е 420) Цей лікарський засіб містить 14,5 міліграма сорбіту на одну дозу. Слід враховувати адитивний ефект (сукупний вплив) від одночасного прийому препаратів, що містять сорбіт (або фруктозу), та споживання сорбіту (або фруктози) разом із їжею. 12. КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ 12.1 Механізм дії Щеплення вакциною КПК II індукує антитіла до кору, паротиту та краснухи, пов'язані із захистом, який можна виміряти за допомогою аналізів на нейтралізацію, тестів інгібування гемаглютинації або методом імуноферментного аналізу (ІФА). Були використані результати дослідження ефективності або дослідження якісної дєвості компонентів вакцин КПК II, проведених раніше, для визначення рівнів сироваткових антитіл, які корелюють із захистом від кору, епідемічного паротиту та краснухи [див. «Клінічні дослідження» (14)]. 12.6 Стійкість відповіді антитіл після вакцинації Нейтралізуючі та імуноферментні антитіла до вірусів кору, паротиту та краснухи все ще виявляються у 95-100%, 74-91% та 90-100% осіб відповідно через 11-13 років після первинної вакцинації. 13. ДОКЛІНІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ 13.1 Канцерогенез, мутагенез, порушення фертильності Вакцину КПК II не оцінювали на предмет канцерогенного чи мутагенного потенціалу чи зниження фертильності 14. КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 14.1 Клінічна ефективність Ефективність вакцин для профілактики кору, паротиту та краснухи була встановлена під час проведення серії подвійних сліпих контрольованих досліджень. У ході цих досліджень також було встановлено, що сероконверсія у відповідь на вакцинацію проти кору, епідемічного паротиту та краснухи сприяє захисту. 14.2 Імуногеність Клінічні дослідження за участю 284 дітей з потрійним серонегативним статусом віком від 11 місяців до 7 років продемонстрували, що вакцина КПК II є імуногенною. У цих дослідженнях однократне введення вакцини індукувало корові антитіла, що інгібують гемаглютинацію, у 95%, паротитні нейтралізуючі антитіла - у 96% та антитіла проти краснухи, що інгібують гемаглютинацію, - у 99% сприйнятливих осіб. Дослідження 6-місячних і 15-місячних немовлят, народжених від матерів, щеплених проти кору в дитинстві, показало, що після вакцинації немовлят і дітей раннього віку живою вакциною проти вірусу кору (раніше ліцензованою в США, виробництва компанії «Merck») у 74% 6-місячних немовлят розвинулися відстежувані титри нейтралізуючих антитіл, тоді як у 100% 15-місячних немовлят, вакцинованих живою вакциною проти вірусу кору або вакциною КПК II, розвинулися нейтралізуючі антитіла. Коли 6-місячні діти імунізованих матерів були ревакциновані у віці 15 місяців вакциною КПК II, у них розвинулися титри антитіл, подібні до титрів антитіл у дітей, які були щеплені раніше в 15-місячному віці. 16 СПОСІБ ПОСТАЧАННЯ/ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВАКЦИНОЮ Вакцина КПК II № 4681 поставляється в наступному вигляді: (1) коробка містить 10 однодозових флаконів з ліофілізованою вакциною (упаковка А) (2) коробка містить один однодозовий флакон ліофілізованої вакцини (3) коробка містить 10 флаконів розчинника (упаковка В) (4) коробка містить однодозовий флакон ліофілізованої вакцини та 1 флакон стерильного розчинника. Не всі розміри упаковок можуть бути представлені на ринку. Вплив світла може інактивувати віруси вакцини. Для забезпечення ефективності вакцину КПК II необхідно зберігати при температурі від -50°C до +8°C. Використання сухого льоду може призвести до того, що вакцина КПК II фактично буде зберігатися за температури нижче -50°C. Перед відновленням (розчиненням) охолодіть ліофілізовану вакцину при температурі від 2°C до 8°C.	Розчинник, що додається, зберігати в холодильнику разом з ліофілізованою вакциною або окремо при кімнатній температурі нижче 30°C. Не заморозуйте розчинник. Вакцину КПК II необхідно ввести якомога швидше після відновлення (розчинення). Якщо вакцину не було введено негайно, відновлену вакцину можна зберігати при температурі від 2°C до 8°C, в захищеному від світла місці, до 8 годин. Утилізуйте відновлену вакцину, якщо вона не була використана протягом 8 годин. 17 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ ПАЦІЄНТАМ Під час інформативної бесіди з пацієнтом: • Надайте пацієнту, батькам або опікуну необхідну інформацію про вакцину. • Проінформуйте пацієнта, батьків або опікуна про переваги та ризики, пов'язані з вакцинацією. • Розпитайте пацієнта, батьків або опікуна про реакції на попереднє введення дози вакцини КПК II або інших вакцин для профілактики кору, паротиту чи краснухи. • Розпитайте жінок з репродуктивним потенціалом про можливість вагітності. Проінформуйте пацієнток про необхідність уникати вагітності протягом 1 місяця після вакцинації [див. розділи «Протипоказання» (4.5) та «Застосування в окремих групах населення» (8.1)]. • Повідомте пацієнта, батьків або опікуна, що щеплення вакциною КПК II може не забезпечити 100% захист від інфекції кору, паротиту та краснухи. • Інструкуйте пацієнтів, батьків або опікунів інформувати їхнього провайдера медичних послуг про будь-які побічні реакції. Вироблено: Корпорація «Мерк Шарп і Доме» (Merck Sharp & Dohme Corp.) Олд Оксфорд Роуд (Old Oxford Road) Дарем, Північна Кароліна, США (Durham, NC, U.S.A.) Випущено: Мерк Шарп і Доме БВ(Merck Sharp & Dohme BV) Харлем, Нідерланди (Haarlem, Netherlands) Власник реєстраційного посвідчення лікарського засобу: Корпорація «Мерк Шарп і Доме» (Merck Sharp & Dohme Corp.) Самнітаун Пайк (Sumneytown Pike) Вест Поінт, США (West Point U.S.A.) Для отримання інформації про патенти: www.merck.com/product/patent/home.html внесено зміни: грудень 2020 року		
--	--	--	--





Профіль: BG210x590_80x40
Перегляд профілю: 0
Дата перегляду профілю: 170919
Розміри (мм): 210 x 590



Поверх наклейки



Без клейкої
поверхні



Без тексту



Фармацевтичний код



Сітка Брайля



Захист від несанкціо-
нованого відкривання
упаковки



Профіль



Перфорація



Лінія згинання

केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला,
केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान,
कसौली, हिमाचल प्रदेश - 173204
फैक्स/0091-1792-272049 - 272016
दूरभाष/0091-1792-272578-272046
मेल : nelkasauli@gmail.com
cdlkasauli@cdsco.nic.in



Central Drugs Laboratory,
Central Research Institute,
Kasauli, Himachal Pradesh-173204
Fax: 0091-1792-272049 -272016
Tel: 0091 -1792-272578 -272046
email id: nelkasauli@gmail.com
cdlkasauli@cdsco.nic.in

National Control Laboratory - Batch Release Certificate

24 APR 2023

Trade name	Diphtheria- Tetanus- Pertussis Vaccine Adsorbed			
Non-proprietary name	Diphtheria- Tetanus- Pertussis Vaccine Adsorbed			
Name and Address of Sample sender	Dr. Sunil Gairola, Executive Director, Serum Institute of India Private Ltd., 212/2, Hadapsar, PUNE – 411 028.			
Sample sender's reference and date	SG/CDL/RELEASE/2023/126 dated 20.03.2023			
Type of container	Vial			
Presentation	5 ml - 10 doses (IM route)			
Prescribed storage temperature	2 ⁰ C - 8 ⁰ C			
License Number	Manufacturing License Number: 10			
Supply	EXPORTS			
The following lot(s) of Diphtheria – Tetanus - Pertussis Vaccine Adsorbed, mfd. by Serum Institute of India Private Limited, Pune in India whose numbers appear on the labels of the final containers, meets all national requirements and WHO requirements for Part 'A' of the Diphtheria-Tetanus and Pertussis Section(s) of the WHO Requirements for Biological Substances No. 8, 10 & 36 (Requirements for Diphtheria, Tetanus, Pertussis and Combined Vaccines, Revised, 2014) and the WHO Requirements for Biological Substances No. 1 (General Requirements for Manufacturing Establishments and Control Laboratories, Revised 1992), are found to be of STANDARD QUALITY and be RELEASED.				
CDL No.	Batch No.	Mfg. Date	Exp. Dt.	Maximum no. of containers & doses for release
1683/2023	2822X010A	JAN-2023	DEC-2024	1,08,008 Vials = 10,80,080 doses
1683/2023	2822X010B	JAN-2023	DEC-2024	92,248 Vials = 9,22,480 doses

These batches have been examined by CDL using documented procedures which form part of a quality system which is in accordance with the ISO/IEC: 17025 standard. As a minimum, this release is based on scrutiny of summary lot protocols (SLPs) and test results information detailed therein by the manufacturer.

Name of Signatory: SUSHIL KUMAR SAHU	Certificate Number: CDL/2023/2575
Designation : DIRECTOR	Date of Release 17 APR 2023
Signature :	

ІНСТИТУТ СІРОВАТКИ КРОВІ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД.

АДСОРБОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ

ОПИС

Адсорбовану вакцину для профілактики дифтерії, правця та кашлюку виготовляють шляхом об'єднання очищеного дифтерійного анатоксину, очищеного правцевого анатоксину та інактивованого збудника кашлюку *Bordetella pertussis*. Антигени адсорбуються на алюмінію фосфаті, який використовують в якості ад'юванта. Тіомерсал присутній в якості консерванту. Вакцина має вигляд сірувато-білої суспензії і не містить протеїнів кінської сироватки, тому не викликає сенсibilізації до сироватки кінського походження. Вакцина відповідає вимогам ВООЗ, стандартам Індійської фармакопеї та Європейської фармакопеї при тестуванні за методами, викладеними в ВООЗ, TRS. 980 (2014), Індійській фармакопеї та Європейській фармакопеї.

СКЛАД

Кожна окрема доза для людини по 0,5 мл містить
Дифтерійний анатоксин ≤ 25 флокулюючих одиниць (≥ 30 МО)
Правцевий анатоксин ≥ 5 флокулюючих одиниць (≥ 40 МО)
Інактивованій збудник кашлюку *B. pertussis* ≤ 16 ОУ (≥ 4МО)
Адсорбований фосфатом алюмінію, Al+++ ≤ 1,25 мг
Консервант: 0,005% Тіомерсал

ПОКАЗАННЯ

Для первинної імунізації проти дифтерії, правця і кашлюку немовлят у віці старше шести тижнів і дітей дошкільного віку. Вакцину можна безпечно та ефективно застосовувати одночасно з вакцинами БЦЖ, вакцинами для профілактики кору, поліомієліту (ІПВ та ОПВ – інактивованими та оральними), гепатиту В, жовтої гарячки, гемофільної інфекції типу b, вітряної віспи та одночасно з вітаміном А.

ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗУВАННЯ

Для первинної імунізації рекомендується робити щеплення трьома окремими дозами по 0,5 мл з приблизними інтервалами між щепленнями від 4 до 6 тижнів. Першу дозу слід вводити приблизно у віці 6 тижнів. Бустерну дозу 0,5 мл слід вводити через 12 місяців після первинної імунізації, а також у віці від 4 до 6 років.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцину АКДП слід вводити внутрішньом'язово. Переважним місцем ін'єкції є передньолатеральна сторона верхньої частини стегна. (Введення вакцини в сідницю дитини може призвести до пошкодження сідничного нерву, отже, такий спосіб введення не рекомендується). Вакцину не слід вводити внутрішньошкірно, так як це може спричинити місцеву реакцію. Для кожної ін'єкції слід використовувати тільки стерильні голки і шприци. Перед застосуванням добре збовтати вакцину. Після відкриття багатодозові флакони слід зберігати з дотриманням температурного режиму в діапазоні від +2°C до +8°C. Багатодозові флакони адсорбованої вакцини проти дифтерії, правця та кашлюку, з яких одна або кілька доз вакцини було взято під час сеансу імунізації, можуть бути використані в наступних сеансах імунізації протягом максимального терміну 28 днів, якщо буде дотримано всіх наступних умов (як описано в Директиві ВООЗ: використання багатодозових флаконів з вакциною після відкриття, WHO/IVB/14.07):

Вакцина наразі є прекваліфікованою ВООЗ;

Вакцину можна використовувати протягом 28 днів після відкриття флакона, згідно з визначенням ВООЗ;

Термін придатності вакцини не минув;

Флакон з вакциною зберігався і зберігатиметься при рекомендованих ВООЗ або виробником температурах; крім того, за наявності флаконного термоіндикатора вакцини на етикетці вакцини, він є видимим і він не вказує на перевищення точки утилізації, і за умови якщо вакцина не була пошкоджена

заморожуванням. Перед введенням, вакцину слід візуально перевірити на наявність будь-яких сторонніх твердих часток та / або на зміну фізичних властивостей. У разі виявлення будь-яких відхилень слід утилізувати вакцину.

Як використовувати ДПК вакцину виробництва Інституту сироватки крові Індії (ISCI) та вакцину проти Hib-інфекції виробництва (ISCI) як чотиривалентну.

ДПК вакцина виробництва ISCI може використовуватися для відновлення вакцини проти Hib інфекції (ISCI) для одночасного введення у вигляді одноразової ін'єкції. Вакцину проти Hib (ISCI) відновлюють наступним чином: додають повний вміст ампули ДПК вакцини (ISCI) або 0,5 мл з багатодозового флакона ДПК вакцини (ISCI). Після додавання ДПК (ISCI) до гранул (ліофілізованої маси) вакцини проти Hib, суміш слід ретельно струсити до повного розчинення гранул Hib в суспензії ДПК вакцини (виробництва ISCI). Після відновлення комбінована вакцина повинна бути негайно введена. Ввести суспензію 0,5 мл шляхом внутрішньом'язової ін'єкції.

ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Поширені незначні місцеві або системні реакції. В багатьох випадках спостерігаються тимчасові незначні набряки, чутливість і почервоніння в місці ін'єкції, що супроводжуються лихоманкою. В деяких випадках протягом 24 годин розвиваються важкі реакції що супроводжуються високою температурою тіла, дратівливістю та плачем. Було зафіксовано випадки розвитку гіпотонічно-гіпореактивних епізодів. Повідомлялося про фебрильні судоми з частотою один випадок на 12500 введених доз. Прийом парацетамолу під час та через 4-8 годин після імунізації знижує подальшу частоту виникнення фебрильних реакцій. Національне дослідження дитячої енцефалопатії у Сполученому Королівстві показало незначний підвищений ризик розвитку гострої енцефалопатії (насамперед судом) після імунізації вакциною АКДП. Однак наступні детальні огляди всіх наявних досліджень ряду груп, включаючи Інститут медицини США, Консультативний комітет з практики імунізації та педіатричні асоціації Австралії, Канади, Сполученого Королівства та США, дійшли висновку, що дані досліджень не встановили наявності причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією АКДП та хронічною дисфункцією нервової системи у дітей. Таким чином, немає наукових доказів того, що гіпотонічно-гіпореактивних епізоди та фебрильні судоми мають будь-які незворотні наслідки для дітей.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

ІН'ЄКЦІЯ АДРЕНАЛІНУ (1:1000) ПОВИННА БУТИ ДОСТУПНА ДЛЯ НЕГАЙНОГО ВВЕДЕННЯ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ГОСТРОЇ АНАФІЛАКТИЧНОЇ РЕАКЦІЇ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКИЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНИ. Для лікування важкої анафілаксії початкова доза адреналіну становить 0,1-0,5 мг (0,1-0,5 мл ін'єкції 1:1000), вводиться підшкірно або внутрішньом'язово. Разова доза не повинна перевищувати 1 мг (1 мл). Для немовлят і дітей рекомендована доза адреналіну становить 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг ін'єкції 1:1000). Разова дитяча доза не повинна перевищувати 0,5 мг (0,5 мл). Основою при лікуванні важкої анафілаксії є оперативне використання адреналіну, який може врятувати життя. Його слід використовувати при першій підозрі на анафілаксію. Так само як і при використанні всіх інших вакцин, вакцинований повинен залишатися під наглядом після вакцинації не менше 30 хвилин для спостереження щодо можливості виникнення негайних або ранніх алергічних реакцій. Гідрокортизон і антигістамінні препарати також повинні бути доступні на додаток до допоміжних заходів, таких як киснева інгаляція. Особливу увагу слід приділити тому, щоб ін'єкція не була введена в кровоносну судину.

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО, ЩОБ КОЛИ ОДИН З БАТЬКІВ ЧИ ОПІКУНІВ ДИТИНИ АБО ДОРΟΣЛИЙ ПАЦІЄНТ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАСТУПНОЇ ДОЗИ ВАКЦИНИ, БАТЬКО (МАТИ), ОПІКУН АБО ДОРΟΣЛИЙ ПАЦІЄНТ МАЮТЬ БУТИ ОПИТАНІ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ СИМПТОМІВ ТА/АБО ОЗНАК ПОБІЧНОЇ РЕАКЦІЇ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДОЗИ.

ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Якщо одночасно вводять вакцину КДП та правцевий або дифтерійний антитоксин, слід використовувати окремі шприци та окремі ділянки тіла для проведення щеплення.

Як і з іншими внутрішньом'язовими ін'єкціями, застосовувати з обережністю у хворих які отримують антикоагулянтну терапію. Імуносупресивна терапія, включаючи опромінення, антиметаболіти, алкілюючі засоби, цитотоксичні препарати та кортикостероїди, що перевищують

фізіологічні дози, може зменшити імунну відповідь на вакцини.

ПРОТИПОКАЗАННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація про гіперчутливість до будь-якого компоненту вакцини або важку реакцію на попередню дозу вакцини, або будь-яку з її складових, є абсолютним протипоказанням до введення наступних доз вакцини або конкретної вакцини, яка, як відомо, спровокувала побічну реакцію. Існує невелика кількість протипоказань для першої дози АКДП – судоми або аномальні церебральні ознаки у немовлят або інші серйозні неврологічні аномалії є протипоказаннями до кашлюкового компонента. При цьому замість вакцини ДПК слід вводити вакцину ДП.

Строки імунізації слід відкласти, якщо у немовляти гостре захворювання. Однак субфебрильну температуру, легкі респіраторні інфекції, недоїдання або діарею не слід розглядати як протипоказання. Немовлятам, які мають неврологічні захворювання в стадії загострення або прогресуючі неврологічні захворювання, включаючи недавні судоми, не слід вводити вакцини, що містять кашлюковий компонент. Натомість слід використовувати для вакцинації адсорбовану вакцину ДП. Другу або наступну дозу вакцини КДП не слід вводити дитині, яка мала важку реакцію на попередню дозу, таку як стійкий плач, шок, судоми або енцефалопатія.

ІМУНОДЕФІЦИТ

Особи, інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), як безсимптомні так із симптоматичними проявами, повинні бути імунізовані вакциною КДП за стандартними графіками.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ВАКЦИНИ

Вакцину слід зберігати при температурі від 2°C до 8°C. Транспортувати вакцину слід також при температурі від 2°C до 8°C. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці з дати виробництва.

ФОРМА ВИПУСКА

1 доза в ампулі 0,5 мл

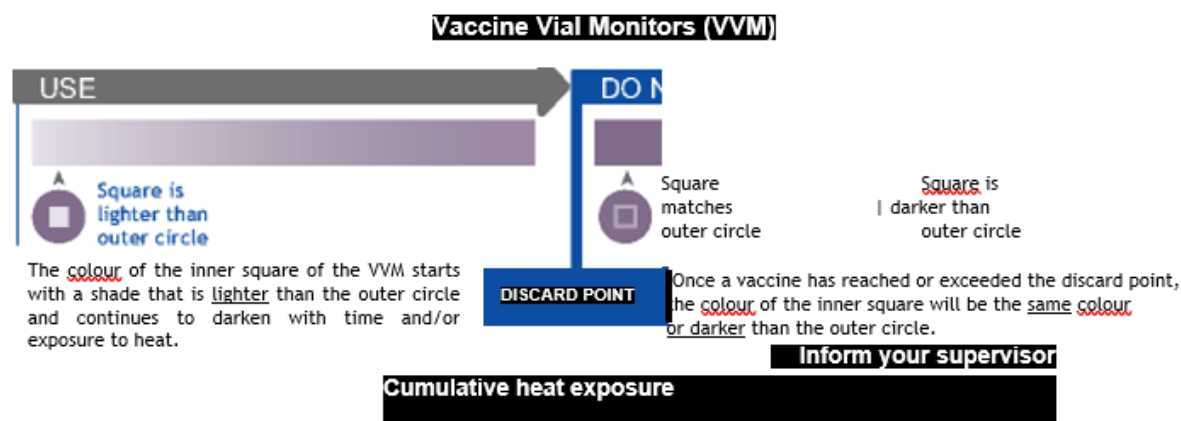
2 дози в ампулі/флаконі 1 мл

10 доз у флаконі 5 мл

20 доз у флаконі 10 мл

Флаконний термоіндикатор (не обов'язково)

Рис. Флаконний термоіндикатор (Vaccine Vial Monitor)



Оригінал	Переклад
Use	Можна використовувати
Square is lighter than outer circle	Колір квадрату світліший за колір зовнішнього кола.
The color of the inner circle of the VVM starts with a shade that is lighter than the outer circle and continues to darken with time and/or exposure to heat.	Колір внутрішньої частини ФТІ починається з відтінку, який є світлішим за колір зовнішнього кола, він продовжує темніти з часом та/або під дією тепла.
Do not use	Не можна використовувати
Square matches outer circle	Колір квадрату такий самий, як і колір зовнішнього кола
Square is darker than outer circle	Колір квадрату темніший за колір зовнішнього кола
Discard point	Точка утилізації
Once a vaccine has reached or exceeded this discard point, the color of the inner circle will be the same color or darker than the outer circle.	Після того, як вакцина досягне або перевищить точку утилізації, колір внутрішньої частини буде таким самим або темнішим за колір зовнішнього кола.
Inform your supervisor	Проінформуйте свого керівника
Cumulative heat exposure	Сукупний вплив тепла

Флакони термоіндикатори (ФТІ) є частиною етикетки адсорбованої вакцини для профілактики дифтерії, правця та кашлюку, що поставляється через Інститут Сироватки Крові Індії Пвт. Лтд. (Serum Institute of India Pvt. Ltd.). ФТІ – це кольорове коло на етикетці флакона. Це чутливий до дії тепла часово-температурний індикатор, який вказує на сукупну дію тепла на флакон. Він попереджає кінцевого споживача про те, коли дія тепла могла змінити якість вакцини до неприйнятного для використання вакцини рівня. Інтерпретація показників ФТІ проста. Зосередьтеся на центральному квадраті. Його колір буде поступово змінюватися. Поки колір цього квадрату світліший, ніж колір зовнішнього кола, вакцину можна використовувати. Як тільки колір центрального квадрату буде такого ж кольору, як зовнішнє коло, або темнішого кольору, ніж зовнішнє коло, флакон слід утилізувати.

Остання редакція: 02/2020

Виробник:
ІНСТИТУТ СИРОВАТКИ КРОВІ ІНДІЇ ПВТ. ЛТД.
212/2, Хадапсар, Пуне 411028, ІНДІЯ
Захист з моменту народження

(SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.
212/2, Hadapsar, Pune 411028, INDIA
Protection from birth onwards)

Причина випуска: оновлена версія тексту	Специфікація: надруковано на тонкому папері щільністю 40 г/м2
Замовник: ВООЗ/ЮНІСЕФ/РАНО	
Продукт - Адсорбована вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку	
Колір:  та Pantone 072C	
Код товару: 20012703/2 Номер специфікації.: Масштаб макету: 100%	
Замінює код товару 20012703/1	Розміри: 353 x 247 мм

РОЗРОБКА УПАКОВКИ	КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ	РЕГУЛЯТОРНІ ПИТАННЯ	МЕДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
-------------------	-----------------	---------------------	----------------------	---------------------

Текст іспанською мовою